

SDG Ziel 3 Gesundheit und Wohlergehen

SDG Unterziel 3.3 Bis 2030 die Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien und die vernachlässigten Tropenkrankheiten beseitigen und Hepatitis, durch Wasser übertragene Krankheiten und andere übertragbare Krankheiten bekämpfen

SDG Indikator 3.3.5 Anzahl der Personen mit Behandlungsbedarf bei vernachlässigten Tropenkrankheiten

Zeitreihe Personen mit Behandlungsbedarf bei vernachlässigten Tropenkrankheiten

1. Allgemeine Angaben zur Zeitreihe

- Stand der nationalen Metadaten: 23. Mai 2023
- Nationale Daten: <https://sdg-indikatoren.de/3-3-5>
- Definition: Die Zeitreihe misst die gemeldete Anzahl vernachlässigter Tropenkrankheiten, die in einem bestimmten Jahr aufgetreten sind.
- Disaggregation: Zeitreihe, Art der Erkrankung

2. Vergleichbarkeit mit den UN-Metadaten

- Stand der UN-Metadaten: März 2026
- UN-Metadaten: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-03-05.pdf>
- Die Zeitreihe entspricht teilweise den UN-Metadaten. Sie umfasst nur die vernachlässigten Tropenkrankheiten: Dengue, Echinokokkose, Lepra und Tollwut.

3. Beschreibung der Daten

- Die Zahl der vernachlässigten Tropenkrankheiten des Robert Koch-Instituts (RKI) basiert auf den Meldungen laborbestätigter Fälle von Denguefieber, Echinokokkose, Lepra nach § 7 (3) Infektionsschutzgesetz (IfSG). Das im Januar 2001 in Kraft getretene Infektionsschutzgesetz (IfSG) regelt, welche Krankheiten bei Verdacht, Krankheit oder Tod meldepflichtig sind. Die Meldung, in der Regel durch Ärzte und Labore, ist obligatorisch. Diese Meldepflicht wird jedoch nicht immer eingehalten, so dass ein Teil der diagnostizierten meldepflichtigen Krankheiten nicht in das Meldesystem aufgenommen wird.

4. Link zur Datenquelle

- Online Datenbank SurvStat@RKI 2.0:
<https://survstat.rki.de/>
- Infektionsepidemiologisches Jahrbuch:
<https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Infektionsepidemiologisches-Jahrbuch/infektionsepidemiologisches-jahrbuch-node.html>

5. Metadaten zur Datenquelle

- Qualitätsbericht – Diagnosen der Krankenhauspatientinnen und -patienten:
<https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Gesundheit/diagnose-krankenhauspatienten.pdf>

6. Aktualität und Periodizität

- Aktualität: t + 3 Wochen nach Datenerhalt
- Periodizität: Jährlich

7. Berechnungsmethode

- Maßeinheit: Anzahl
- Berechnung: Nicht zutreffend.

SDG Ziel 3 Gesundheit und Wohlergehen

SDG Unterziel 3.3 Bis 2030 die Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien und die vernachlässigten Tropenkrankheiten beseitigen und Hepatitis, durch Wasser übertragene Krankheiten und andere übertragbare Krankheiten bekämpfen

SDG Indikator 3.3.5 Anzahl der Personen mit Behandlungsbedarf bei vernachlässigten Tropenkrankheiten

Zeitreihe Stationäre Behandlung bei vernachlässigten Tropenkrankheiten

1. Allgemeine Angaben zur Zeitreihe

- Stand der nationalen Metadaten: 20. Mai 2022
- Nationale Daten: <https://sdg-indikatoren.de/3-3-5>
- Definition: Die Zeitreihe misst die Anzahl der in Krankenhäusern behandelten Patientinnen und Patienten mit Diagnose vernachlässigter Tropenkrankheiten klassifiziert mit den folgenden ICD-10-Diagnosecodes:

A30: Lepra
A31.1: Buruli-Ulkus
A66: Frambösie
A82: Tollwut
A97: Dengue
B55: Leishmaniose
B56: Afrikanische Trypanosomiasis
B67: Echinokokkose
B72: Drakunkulose

ICD-10 ist die 10. Version der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (deutsche Modifikation).

- Disaggregation: Zeitreihe, Art der Erkrankung

2. Vergleichbarkeit mit den UN-Metadaten

- Stand der UN-Metadaten: März 2026
- UN-Metadaten: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-03-05.pdf>
- Die Zeitreihe entspricht teilweise den UN-Metadaten. Sie deckt nur die stationäre Behandlung ab.

3. Beschreibung der Daten

- Die Daten stammen aus der Krankenhausstatistik des Statistischen Bundesamtes.
 - o Afrikanische Trypanosomiasis: Parasitäre Erkrankung durch *Trypanosoma brucei* in Afrika, die zu einer tödlichen Enzephalopathie führt. Sie wird durch Tsetsefliegen übertragen. Behandelt wird die afrikanische Trypanosomiasis vorzugsweise stationär in einer tropenmedizinischen Einrichtung.

- o Buruli-Ulkus: Chronisches Haut-Geschwür, meist bei Kindern, hervorgerufen durch *Mycobacterium ulcerans*. Das Buruli-Ulkus kommt vor in West- und Zentralafrika, seltener in Lateinamerika, Papua-Neu-Guinea und im Norden Australiens. Der Erreger wird wahrscheinlich durch kleine Hautverletzungen oder Insektenstiche übertragen. Behandelt wird chirurgisch, antibiotisch und physiotherapeutisch (Vermeidung von Narbenkontrakturen).
- o Dengue: Schwere, akut fieberige Infektion durch das Dengue-Virus in tropischen und subtropischen Gebieten. Übertragen durch die Gelbfiebermücke (*Aedes aegypti*, synonym *Stegomyia aegypti*) oder asiatische Tigermücke (*Aedes albopictus* oder *Stegomyia albopicta*), breitet sich die Infektion in den letzten Jahrzehnten aus. Bei rechtzeitiger Behandlung liegt die Letalität unter 1 %.
- o Drakunkulose: Fast ausgerottete tropische Wurmerkrankung mit *Dracunculus medinensis*. Der adulte Wurm lebt im Unterhautgewebe. Durch ein Geschwür gelangen die Larven ins Wasser, die dort Wasserflöhe (Hüpfertiere) befallen. Bei Aufnahme dieser Zwischenwirte durch das Trinkwasser, wandern die Larven ins Gewebe. Behandelt wird durch Extraktion des Wurms.
- o Echinokokkose: Infektionskrankheit durch Finnen des Hundebandwurms oder Fuchsbandwurms. Meist ist die Leber betroffen. Unterschieden werden die zystische Echinokokkose mit abgekapselten Hydatiden-Zysten durch Finnen des Hundebandwurms (*Echinococcus granulosus*) und die alveoläre Echinokokkose mit invasiv wachsenden Hydatiden-Zysten durch Larven des Fuchsbandwurms (*Echinococcus multilocularis*).
- o Frambösie: Chronische Infektionskrankheit durch Kontaktinfektion mit *Treponema pertenue* (tropische Treponematose). Anfangs zeigen sich Hautläsionen, im Spätstadium kommt es zur Verdickung der Leistenhaut und Knochenverformung. Die Frambösie tritt meist auf bei Kindern in den feuchtheißen Gebieten Afrikas, Lateinamerikas und Asiens. Einmaldosen von Antibiotika sind wirksam.
- o Leishmaniose: Infektionskrankheit durch Leishmanien (intrazelluläre Protozoen). Die Einteilung der Erreger in zahlreiche Spezies ist im Fluss. Sandmücken (*Phlebotominae*) übertragen den Parasiten von verschiedenen Säugetieren auf den Menschen. Symptomatik und Prognose hängen vom Erreger und der Erkrankungsform ab. Therapeutisch verwendet man hauptsächlich Amphotericin B und Antimonpräparate.
- o Lepra: Durch *Mycobacterium leprae* verursachte Infektionskrankheit der Haut, Schleimhäute und peripheren Nerven mit trophischen und sensiblen Störungen, Lähmungen und letztlich Deformation.
- o Tollwut: In Deutschland sehr seltene, durch das Tollwutvirus verursachte Infektionskrankheit mit infauster Prognose. Tollwut wird hauptsächlich durch den Biss infizierter Tiere übertragen. Prophylaktische und postexpositionsprophylaktische Impfungen sind verfügbar, bisher gibt es jedoch keine spezifische Therapie. Es besteht Meldepflicht nach § 6 und 7 Infektionsschutzgesetz.

4. Link zur Datenquelle

- GBE – Tabelle: Diagnosedaten der Krankenhäuser nach Behandlungsort (ICD10-4-Steller) [Einstellungen: Hierarchie: KH 4-Steller Kapitel I; ICD10: A30, A31.1, A66, A82, A97, B55, B56, B67, B72]:
<https://www.gbe-bund.de/gbe/>

5. Metadaten zur Datenquelle

- Qualitätsbericht – Diagnosen der Krankenhauspatientinnen und -patienten:
<https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Gesundheit/diagnose-krankenhauspatienten.pdf>

6. Aktualität und Periodizität

- Aktualität: t + 12 Monate
- Periodizität: Jährlich

7. Berechnungsmethode

- Maßeinheit: Anzahl
- Berechnung: Nicht zutreffend.